

專業治療

- └─ 1. 骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術
- └─ 2. 微創腰椎手術 | 內視鏡/顯微減壓與固定融合
- └─ 3. 微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合
- └─ 4. 腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療
- └─ 5. 神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制
- └─ 6. 骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

微創腰椎手術 | 內視鏡／顯微減壓與固定融合

透過微創切口，精準解除神經壓迫；必要時重建脊椎穩定，幫助您擺脫腰痛腳麻，重獲行走自由。

當腰椎因為退化、骨刺增生、椎間盤突出或關節鬆動滑脫，壓迫到神經或造成脊椎不穩定時，常會引發腰痛、屁股痠痛、腳麻、坐骨神經痛，甚至走沒幾步路就必須坐下或蹲下休息。

很多患者一聽到「腰椎手術」，就擔心是不是一定要打骨釘、傷口很大、恢復很慢，甚至因此拖到腳麻越來越嚴重、走路越來越困難。

其實，微創腰椎手術不是單一種手術，也不是每一位患者都需要固定融合。

真正重要的是判斷：

神經壓迫在哪裡？

脊椎結構穩不穩？

只需要減壓，還是需要同時重建穩定度？

相較於傳統較大傷口的腰椎手術，微創腰椎手術希望在達到治療目的的同時，減少對背部肌肉與正常組織的破壞。

治療重點在於：

精準減壓、最小破壞、必要時重建穩定。

微創腰椎手術有哪些方式？

不是每一個腰椎問題都需要「打骨釘」。

醫師會依照脊椎是否穩定、神經壓迫的位置與範圍、症狀嚴重度、肌肉狀況與生活需求，評估最適合的手術策略。

1. 微創腰椎減壓手術

內視鏡／顯微鏡減壓術

微創腰椎減壓手術的概念，是在盡量保留原本脊椎結構的情況下，移除壓迫神經的病灶。

手術會透過小傷口，在內視鏡或顯微鏡的放大視野下，精準處理壓迫神經的肥厚韌帶、骨刺或突出的椎間盤。

適合情況包括：

- 脊椎結構仍然穩定
- 單純腰椎椎管狹窄，造成走不遠、站不久
- 椎間盤突出引發坐骨神經痛
- 保守治療後仍反覆腳麻、腿痛
- 影像位置與症狀相符
- 不需要做脊椎固定融合者

這類手術的重點是：

替神經打開空間，但盡量保留原本健康的骨骼與肌肉結構。

2. 微創腰椎固定與融合手術

微創融合術／皮下骨釘固定

如果腰椎不只是神經被壓迫，還合併脊椎滑脫、走位、不穩定或嚴重退化，單純減壓可能不夠。

這時候，就可能需要評估微創腰椎固定與融合手術。

手術會在減壓的同時，透過微創通道清除壓迫神經的病灶，並依照病況置入椎間支架與骨釘固定，幫助不穩定的腰椎重新建立支撐。

適合情況包括：

- 腰椎滑脫，俗稱脊椎走位

- 腰椎動態不穩定
- 嚴重脊椎退化合併神經壓迫
- 復發性椎間盤突出合併脊椎失穩
- 久坐後站不起來，腰部使不上力
- 腰部感覺「空空的」、「撐不住」
- 單純減壓可能無法解決問題者

固定融合的重點不是「打骨釘」本身，而是在脊椎已經不穩定時，重新建立支撐，避免神經壓迫反覆發生。

固定融合手術的支架、骨釘都要自費嗎？

不一定。

微創腰椎固定與融合手術常會使用椎間支架、骨釘等植入物，幫助脊椎重新建立穩定度。

符合健保條件時，部分手術與基本植入物可評估申請健保給付；但如果希望使用特殊材質、特殊設計或功能較進階的植入物，也可能會有自費或差額負擔的選項。

簡單來說：

健保選項，是在符合條件下提供基本治療需求。

自費或差額負擔選項，則可能在材質、設計、骨整合、影像相容性或微創操作便利性上有所不同。

微創腰椎術式快速比較

比較項目	微創腰椎減壓手術	微創腰椎減壓與融合手術	傳統開放式腰椎手術
治療概念	幫受壓迫的神經打開空間	神經減壓，同時重建脊椎穩定	透過較大傷口直接暴露脊椎進行減壓或固定
常見方式	內視鏡或顯微鏡減壓	微創融合、椎間支架與皮下骨釘固定	傳統開放式減壓、融合與骨釘固定
結構處理	盡量保留原本脊椎結構	清除病灶後，固定不穩定節段	需要較大範圍剝離肌肉與暴露骨骼結構
傷口大小	約 0.8–1.5 公分小傷口	數個約 2 到 5 公分左右小傷口	傷口可能約 10–20 公分，依手術節數而異

肌肉破壞	最少	較傳統開放手術少	較多，術後疼痛與僵硬感通常較明顯
適合對象	脊椎穩定、單純神經壓迫者	腰椎滑脫、動態不穩、嚴重退化者	複雜變形、多節段病灶或需要大範圍處理者
恢復期	通常較快恢復下床活動	依固定節數與身體狀況幾日內逐步恢復	通常恢復期較長，部分患者需數週至一個月休養
手術重點	精準減壓	減壓加穩定	大範圍處理與結構重建

簡單來說：

如果只是神經被壓迫，脊椎仍然穩定，通常以減壓為主。

如果脊椎已經滑脫、走位或不穩定，就可能需要固定融合。

如果是複雜變形、多節段嚴重退化或需要大範圍重建，傳統開放式手術仍有其必要性。

微創手術的價值，不是單純追求傷口小，而是在達到治療目的的同時，盡量減少肌肉破壞、降低術後疼痛，幫助患者更早恢復活動。

微創腰椎手術的優點

微創腰椎手術的核心價值，是在達到治療目的的同時，盡量減少對正常肌肉與組織的破壞。

常見優點包括：

- 傷口較小：透過微創通道處理病灶，減少大範圍肌肉剝離
- 組織破壞較少：盡量保留正常背部肌肉與骨骼結構
- 精準減壓：在內視鏡或顯微鏡放大視野下，處理真正壓迫神經的位置
- 失血量相對較少：對高齡者或慢性病患者，身體負擔通常較低
- 恢復較快：多數患者術後可在醫師評估下，逐步下床活動與復健
- 治療選擇彈性：依病況選擇減壓、內視鏡、顯微鏡或固定融合

但微創不代表每個人都適合同一種手術。

真正重要的不是傷口越小越好，而是選對治療方式。

什麼情況不能再拖？

如果腰痛、腳麻、腿痛已經反覆影響生活，建議儘早門診評估。

尤其出現以下情況，更應該提高警覺：

- 腳麻、腳痛越來越嚴重
- 走路距離越來越短
- 站不久、走不遠，生活明顯受限
- 腳無力、走路拖腳
- 腰部使不上力，感覺撐不住
- 保守治療後症狀仍反覆發作

如果已經出現明顯腳無力、無法行走、大小便控制異常或會陰部麻木，可能代表神經受到嚴重壓迫，應立即就醫，必要時不要等待門診，應直接到急診評估。

文宏裕醫師的治療觀點

許多患者一聽到「腰椎要開刀」或「要打骨釘」，就嚇得不敢就醫，結果一路忍到腳麻加重、肌力下降，甚至走路越來越困難。

其實，微創腰椎手術不是每個人都要固定融合。

如果只是單純神經壓迫、脊椎結構仍然穩定，能用微創減壓處理的，我不會輕易建議打骨釘。

但如果腰椎已經滑脫、走位或不穩定，單純減壓可能不夠，這時候就需要評估是否透過微創固定融合，幫脊椎重新建立穩定支撐。

治療不是為了做多大的手術，而是選擇最適合您的方式。

如果腰痛、腳麻、坐骨神經痛或走不遠已經影響生活，就不要只是一直忍耐。讓專業醫師協助您判斷，才能選擇最適合的治療方式。

不該開的刀，我不開；該開的刀，我做到最好。

手術不是目的，重新回到生活才是目的。

把時間留給生活，不留給疼痛。